

권 고 사 항

1. 제 목 : 요양병원 인력확보 수준에 따른 입원료 차등제 관리에 관한사항
2. 관계기관 : ○○병원
3. 내 용 : ○○병원에서는 환자의 상태에 적합한 진료서비스 제공을 위하여 399병상 규모의 요양병원을 운영하고 있습니다.

요양병원 급여 목록 및 상대가치점수에 따르면 요양병원은 환자의 상태에 따른 일당 정액수가를 기본으로 하면서 직전분기(3개월) 동안 입원환자 대비 상근하는 의사와 간호사 수를 비교하여 등급을 산정한 후 다음분기 동안 입원료를 적용하는 입원료 차등제를 시행하고 있습니다.

[표 1] 인력확보에 따른 입원료 차등제 내역

구분	등급	기준	수가적용
의사	1등급	35:1	전문의 50%이상 - 20%가산 전문의 50%미만 - 10%가산
	2등급	35:1초과 40:1이하	소정점수
	3등급	40:1초과 50:1이하	소정점수 15%감산
	4등	50:1초과 60:1이하	소정점수 30%감산
	5등급	60:1초과	소정점수 50%감산
간호사	1등급	4.5:1 미만	소정점수 60%가산
	2등급	4.5:1이상 5:1미만	소정점수 50%가산
	3등급	5:1이상 5.5:1미만	소정점수 35%가산
	4등급	5.5:1이상 6:1미만	소정점수 20%가산
	5등급	5.5:1이상 6:1미만	소정점수 산정
	6~8등급	6:1이상 구간별 부여	20~50%감산

이와같이 인력 확보수준에 따라 수가 차등제가 적용될 때에는 필요 인력은 적기에 수급하여 당초 계획한 등급을 적용받을 수 있도록 관리하여야 하며, 인력 확보 수준에 따라 손익을 비교하여 요양병원을 합리적으로 운영할 수 있는 최적의 등급 수준을 설정하고 운영하여야 합니다.

그런데 요양병원의 차등수가 적용 실태 확인결과 [표 2] 와 같이 간호인력과 의사 확보율 모두 '16년에는 2등급을 적용받고 있는데, 1등급 기준과 비교시 그 차이가 크지 않았으며, '16.1분기 요양병원 입원환자를 기준으로 등급차에 따른 분기 수익 차이를 비교한 결과 [표 3] 과 같이 간호는 61백만 원, 의사는 123백만 원 상당이 발생하는 것으로 검토되었습니다.

[표 2] 요양병원 입원료 차등제 적용내역

구분		'16.2분기	'16.1분기	'15.4분기	'15.3분기	'15.2분기	15.1분기
환자수		378.34	384.58	380	393.78	392.78	380.56
간호	인력	81.67	82	82.67	96.66	97	97
	비율	4.63	4.68	4.59	4.07	4.04	3.92
	등급	2등급	2등급	2등급	1등급	1등급	1등급
	1등급 부족인력	2.4	3.46	1.77			
의사	인력	9.86	9.95	11.67	12.42	10.71	9.69
	비율	38.37	38.65	32.56	31.70	36.67	39.27
	등급	2등급	2등급	1등급	1등급	2등급	2등급
	1등급 부족인력	0.95	1.04	-	-	0.51	1.18

※ 분기는 등급 적용분기 기준

[표 3] 인력확보에 따른 입원료 차등제 내역

구분		연인원	의사2, 간호2	의사1, 간호1		의사1, 간호2		의사2, 간호1	
				단가	입원료차액	단가	입원료차액	단가	입원료차액
최고도	count3-6	514	67,120	72,870	2,955,500	70,950	1,968,620	69,030	981,740
	count1-2	237	59,800	65,550	1,362,750	63,630	907,710	61,710	452,670
고도	ADL 17-20	13,753	57,470	63,220	79,079,750	61,300	52,673,990	59,380	26,268,230
	ADL 9-16	202	55,200	60,950	1,161,500	59,030	773,660	57,110	385,820
	ADL 4-8	133	50,640	56,390	764,750	54,470	509,390	52,550	254,030
중도	ADL 16-20	4,576	54,010	59,760	26,312,000	57,840	17,526,080	55,920	8,740,160
	ADL 9-15	2,657	52,110	57,860	15,277,750	55,940	10,176,310	54,020	5,074,870
	ADL 4-8	125	50,000	55,750	718,750	53,830	478,750	51,910	238,750
인지장애	ADL 4-20	4,976	49,490	55,240	28,612,000	53,320	19,058,080	51,400	9,504,160
신체기능 저하	ADL 13-20	3,064	39,850	45,600	17,618,000	43,680	11,735,120	41,760	5,852,240
	ADL 6-12	1,938	37,850	43,600	11,143,500	41,680	7,422,540	39,760	3,701,580
	ADL 4-5	7	34,640	40,400	40,250	38,480	26,810	36,560	13,370
계					185,046,500		123,257,060		61,467,620

그런데 의사직의 경우는 [표 4] 와 같이 퇴직자에 대한 대체자 임용 지연이 등급 하락의 주요 원인이었으며, 간호인력은 운영 효율화 측면에서 목표 등급 재 검토가 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 의사직 퇴직 대체자 확보기간

직종	성명	담당업무	사직신청일	퇴사일	대체자모집공고	대체자 임용일
일반의	***	당직의	'15. 2. 3.	'15. 2.15.	'15. 1.27.	'15. 3. 1.
일반의	***	당직의	'15. 9.21.	'15.10. 4.	'15. 9.21.	'16. 2.11.
일반의	***	당직의	'15.10. 5.	'15.10.11.	'15.10. 2.	모집중
전문의	***	주간진료		'15.10.26.	'15.10. 6.	'15.11. 2.

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 인력확보 수준에 따라 차등수가가 적용되는 요양병원 의사와 간호직종은 현재 2등급을 적용받고 있으나 1등급에 가까운 2등급임을 감안하여 경영수지 등을 고려한 목표 등급을 명확히 하여 운영하여 주시기 바라며,**(권고)**
- 퇴직 등으로 인하여 인력 공백이 발생할 경우 퇴직시기 조기 인지로 대체 인력 적기확보 등 계획적인 인사가 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.**(통보)**